המועצה המדעית
SCIENTIFIC COUNCIL
ההסתדרות הרפואית בישראל
Israeli Medical Association
חינוך רפואי זו ההתמחות שלנו

המועצה המדעית ועדת הבחינות

בחינות שלב א'

גריאטריה בסיס

30.09.24

מס' השאלות בחלק זה:100

בחינת שלב א' גריאטריה בסיס 30.09.24

1. מה מהבאים מוכח במחקרים כיעיל במניעת נפילות בקשישים בקהילה?
   א. התאמת הבית והסרת מכשולים כגון ריהוט נמוך ושטיחים
   ב. תוסף ויטמין D
   ג. שימוש במשקפי ביפוקאל לתיקון הראיה
   ד. פסיכותרפיה למניעת חרדת נפילה

2. איזה מהבאים מתאר נכונה את הטיפול להאטת קצב במטופל הסובל מפרפור פרוזדורים?
   א. הטיפול ב- DIGOXIN מועדף לחולים עם אי ספיקת כליות
   ב. טיפול בחוסמי סידן מקבוצת dihydropyridine מהווה קו ראשון בטיפול
   ג. הטיפול בחוסמי בטא יכול לגרום להפרעות הולכה
   ד. טיפול בחוסמי סידן מסוג non-dihydropyridine מועדף לחולים עם אי ספיקת לב

3. לפי קריטריוני FRIED, מי מהבאים מתאים לאבחנה של שברירות?
   א. בת 80, ירדה במשקל 2 ק"ג בשנה האחרונה, הולכת במהירות איטית ומתלוננת על חולשה בניקיונות הבית
   ב. בן 80, מתקשה בהליכה, אינו מסוגל להרים סל קניות, ללא ירידה במשקל, מתעייף לאחר ביצוע מעברים
   ג. בת 75, מסוגלת לאחוז ולהרים סל קניות, מתעייפת לאחר ניקיונות הבית, ירדה 1 ק"ג בחודש האחרון
   ד. בן 90, נוהג ללכת למועדון כל יום, נזקק לעזרה בקניות, ללא ירידה במשקל

4. מבין המטופלים הבאים, מי מתאים לאבחנה של מטופל עם דמנציה עם הפרעות בהתנהגות?
   א. בן 77, הסובל מירידה קוגניטיבית לאחרונה, מאד עצוב עם מחשבות אובדניות
   ב. בת 84, הסובלת מהדרדרות קוגניטיבית חדה בשבועיים האחרונים. ביומיים האחרונים אינה ישנה ומרביצה לבני המשפחה
   ג. בת 75, הדרדרות קוגניטיבית בשלוש שנים האחרונות, סובלת משוטטות ולאחרונה החלה להתפשט בביתה מול כולם ולצעוק בלילות
   ד. בן 81, עם ירידה קוגניטיבית בחמש השנים האחרונות. ביומיים האחרונים ישן רוב היום

5. איזו תרופה מהתרופות נוגדות הדיכאון הבאות בעלת הסיכון הנמוך ביותר לגרום להיפונתרמיה?
   א. Sertraline
   ב. Mirtazapine
   ג. Venlafaxine
   ד. Bupropion

6. מה סביר למצוא ב- EEG במטופל הסובל מדליריום?
   א. האטה גלובלית עם גלי אלפא
   ב. ספייקים מרובים פוקאלים
   ג. גלים מחודדים באיזור האונה הטמפוראלית
   ד. הופעת גלים ביפאזים וטריפאזים

7. איזה טיפול מומלץ כטיפול בקצב הלב RHYTHM CONTROL למטופל הסובל מפרפור פרוזדורים לאחר אשפוז בעקבות החמרה באי ספיקת לב עם NYHA IV?
   א. Flecainide (Tambocor)
   ב. Propafenone (Rythmex)
   ג. Amiodarone (Procor)
   ד. Dronaderone (Multaq)

8. בת 90 עם נגע חדש המופיע בתמונה מספר 1.
   מה נכון לגבי הממצא?
   א. להפנות לרופא עור לצריבה עם חנקן
   ב. לשלוח לפלסטיקאי לביופסיה
   ג. להתחיל טיפול מקומי במשחה עם סטרואידים
   ד. המשך מעקב בעוד 3 חודשים

9. בת 82 מתלוננת על נפילות, סחרחורות, חולשה, בחילות. תסמינים אלו מחמירים במעבר משכיבה לעמידה. לחץ דם נמדד בשכיבה – 130/80ובעמידה 125/65. מה יכול לעזור למטופלת זו?
   א. שינה עם הרמה של הראש בזווית של 30-45 מעלות
   ב. להימנע מסביבה קרה
   ג. הגבלת צריכת מלח
   ד. להימנע מקפה ועישון

10. בן 57 מתחיל לפתח הפרעות בזיכרון ובעיות בתפקודים ניהוליים. אמו סבלה ממחלת אלצהיימר ונפטרה בגיל 68, דוד שלו אובחן כלוקה במחלת אלצהיימר בגיל 61 ונפטר בגיל 73.
    מה נכון בנוגע לסיכון שלו לפתח מחלת אלצהיימר?
    א. אם ימצא גן הגורם למחלתו, ככל הנראה מדובר בפגם בגן הפריסינלין (PSEN1)
    ב. ברוב המקרים של Early Onset Alzheimer, ניתן למצוא סיבה גנטית ברורה
    ג. אם המטופל הטרוזיגוטי לגן APOE ε4 הסיכוי להתפתחות מחלת אלצהיימר מעל 50%
    ד. הגן ל- MAPT (Microtubule Associated Protein Tau) מנבא התדרדרות מהירה יותר במחלת אלצהיימר

11. בת 70 אובחנה לאחרונה עם כולנגיוקרצינומה, אושפזה לאיזון תסמינים משניים למחלתה המתקדמת ולטיפול הכימי. תלונתה העיקרית היא בחילה אשר לא הגיבה ל- Ondansetron (Zofran) ול- Metoclopramide (Pramin) . באנמנזה, מעבירה גזים, שוללת עצירות או שלשולים. כאב מאוזן תחת Targin.

מה מהטיפולים הבאים מתאים?

א. Haloperidol

ב. Escitalopram

ג. Amantadine

ד. Lactulose

12. בן 85, ברקע הגדלה שפירה של הערמונית, ללא עדות לממאירות, ללא התערבות ניתוחית. מתלונן על בריחת שתן, מתוסכל כי הוא כמעט תמיד רטוב ולא שם לב כאשר הוא מאבד שתן. כשהוא כן הולך לשירותים כדי להטיל שתן, יש לו קושי להתחיל זרם שתן ויש לו קצת היסוס לאחר מכן. תחת טיפול תרופתי בחסמי אלפא.

מהו הטיפול המומלץ?

א. תרגילים לחיזוק שרירי רצפת האגן (קיגל)

ב. מקבוצת ה- Bladder Relaxants

ג. התערבות פולשנית להקטנת/הסרת הערמונית

ד. טיפול התנהגותי

13. בת 75, ברקע סוכרת. התאלמנה לפני כחצי שנה, ומאז מצב רוחה ירוד. לאחרונה מתלוננת על כאבי גב תחתון. בבירור אובחנה דיסקופתיה מותנית ללא חסר נוירולוגי, מקבלת Optalgin ו- Acamol סביב השעון וטיפולי פיזיותרפיה, אך עדיין ללא הטבה משמעותית, ישנה מגבלה תפקודית וממעטת לצאת מהבית בגלל כאבים.

מה הטיפול התרופתי שמומלץ להתחיל בשלב זה?

א. Duloxetine (Cymbalta) 30 מ"ג ליום

ב. מדבקת Fentanyl במינון 25 מק"ג

ג. Pregabalin (Lyrica) במינון 300 מ"ג ליום

ד. Escitalopram במינון 10 מ"ג ליום

14. מהי ההמלצה הנכונה למטופל תחת טיפול אנטיקואגולנטי שאמור לעבור ניתוח?

א. מומלץ להמתין חודש ימים לאחר אירוע של DVT לפני ביצוע ניתוח אלקטיבי

ב. מטופל המקבל COUMADIN יכול להפסיק טיפול ללא צורך בגישור על ידי CLEXAN ולחדש בהמשך

ג. מטופל המקבל RIVAROXABAN יכול להפסיק טיפול ללא צורך בגישור על-ידי CLEXAN ולחדש בהמשך

ד. במטופל לאחר תסחיף ריאתי לא מומלץ לבצע ניתוח אלקטיבי עד שנה לאחר האירוע

15. איזו דמנציה מאופיינת עם אובדן אמפתיה?
    א. Alzheimer's Dementia
    ב. Vascular Dementia
    ג. Lewy Bodies Dementia
    ד. Frontotemporal Dementia

16. מה יכול לשפר את פעילות המעי הגס ולהפחית עצירות?
    א. קפה שחור
    ב. VERAPAMIL
    ג. תוספי סידן
    ד. ELATROL (AMI)

17. מה נכון בנוגע לטיפול בתרופות אדג'ובנטיות לטיפול בכאב כרוני בזקנים?
    א. תרופות ממשפחת ה- Tricyclics מהוות קו ראשון לטיפול בכאב נוירופתי
    ב. ל- Venlafaxine יתרון בטיחותי במניעת נפילות ושברים
    ג. לטיפול ב- Carbamazepine סיכון להיפונתרמיה
    ד. טיפול ב- Gabapentin מחייב מעקב הדוק אחר רמות תרופה בדם

18. איזה מסוגי השאלות הבאות נשאלות בשאלון AMT4?
    א. שאלות על התמצאות
    ב. שאלות על תפקוד
    ג. שאלות על מצב בריאותי
    ד. שאלות על טיפול תרופתי

19. בן 75, סובל מנפילות חוזרות. ברקע סוכרת ואוסטאוארתריטיס. מה מבין הבאים מנבא סיכון לנפילות עתידיות?
    א. ערך צפיפות עצם T-SCORE של -2.7 .
    ב. ירידה של 10 mmHg בלחץ הדם הסיסטולי במעבר בין שכיבה לעמידה.
    ג. זמן ביצוע Alternate Step Test מתוזמן ב- 17 שניות להשלמת 8 צעדים
    ד. זמן ביצוע Timed Up & Go מתוזמן ב- 10 שניות

20. מה מהבאים מהווה סיבוך של היצרות המסתם האאורטלי?
    א. חסם עלייתי חדרי
    ב. השטחה של המיקרווילי ברירית המעי הדק
    ג. הפרעה בתפקוד הטסיות
    ד. עליה ברמות VON WILLEBRAND FACTOR

21. לפי ה- CLINICAL FRAILTY SCALE איזה ציון יקבל מטופל מרותק לכיסא גלגלים?
    א. ציון 1
    ב. ציון 3
    ג. ציון 4
    ד. ציון 7

22. בן 67, חזר לביקורת לאחר חצי שנה של טיפול תרופתי לדחיפות במתן שתן (URGENCY INCONTINENCE). ברקע הגדלה שפירה של הערמונית. הוא מדווח על הפרעה בתפקוד המיני והופעת גניקומסטיה. מה התרופה שגרמה לתופעות הלוואי המתוארות?
    א. Tadafil (Phosphodiesterase Inhibitor)
    ב. Finasteride (5-Alpha-Reductase Inhibitor)
    ג. Mirabegron (Beta-3-Agonist)
    ד. Oxybutinin (Anticholinergic)

23. בן 70 מגיע בליווי אשתו למרפאה לבירור נפילות חוזרות מזה מספר חודשים. באנמנזה מספר על נפילות בעיקר סביב שינוי תנוחה. בנוסף, הוא סובל מעצירות ומתקשה לשמר שינה לאורך לילה שלם. אשתו מציינת שבשנים האחרונות משמיע קולות בעת שישן. הוא שולל הזיות ראיה. בבדיקתו - דיבור עם הגייה לא ברורה, מבחן אצבע-אף לקוי, טונוס שמור, ירידת ל"ד אורתוסטטית.
    ציון MoCA 27.
    מה האבחנה המתאימה?
    א. Multiple System Atrophy MSA-C
    ב. Lewy Body Dementia
    ג. Parkinson's Disease
    ד. Spinocerebellar Ataxias

24. מה מהבאים מהווה קריטריון תומך לאבחנה של פרקינסון לפי ה-MDS (Movement Disorder Society)?
    א. ריור מוגבר
    ב. רעד במנוחה
    ג. אטרופיה צרבלרית בהדמייה
    ד. נפילות או קפאון בהליכה בשלב מוקדם

25. מי מהבאים סובל מדליריום על פי הקריטריונים של CAM -Confusion Assessment Method ?
   א. בן 91 עם דמנציה מתקדמת שבחודשים האחרונים צועק ברוב שעות היום והלילה, משפחתו הביאה אותו לאשפוז כי לא מסתדרים איתו בבית. גם באשפוז באי שקט תמידי, אינו ממלא הוראות, זיכרון קצר טווח מאוד לקוי.
   ב. בת 82 עם UTI, ברקע דמנציה בינונית. ישנונית מאוד, מתמצאת במקום ובסיטואציה, אך נרדמת תוך כדי משפטים ואינה מצליחה למלא משימות פשוטות כמו לאיית את שמה לאחור. דווח כי בלילה הייתה באי שקט וניסתה לצאת מהמיטה.
   ג. בת 75 חצי שנה לאחר אירוע מוחי , משתפת פעולה ומבצעת הוראות. מאז האירוע המוחי תפקודי זיכרון, שפה וקשב פגועים ביחס למצבה הבסיסי לפני האירוע.
   ד. בן 78, מאושפז בשל כאבים בחזה ומסרב לעבור את הצנתור שהומלץ לו. בכל פעם שנכנס איש צוות לחדר מקלל וצועק. כשנשאל על ידיכם שאלות התמצאות או שאלות לגבי מצבו עונה בעצבנות "לא יודע".

26. בת 74, עם השמנת יתר, מתלוננת על כאב ברכיים. הכאב מוחמר בזמן פעילות, מוקל במנוחה. מתארת כאב חד לסירוגין, בעיקר בבוקר או לאחר מנוחה ממושכת המלווה בנוקשות אשר חולפת תוך כחצי שעה.בבדיקה גופנית רגישות במישוש הברך, אי סדירות וקריפיטציות. בוצע צילום ברכיים. אילו ממצאים בצילום יאשרו את האבחנה הקלינית?
   א. היצרות המרווח הטיביו-פמורלי, אוסטאופיטים
   ב. עבוי קורטיקלי, אזורים סקלרוטיים וטרבקולות גסות
   ג. אוסטאופניה ונגעים ליטיים
   ד. תגובה פריאוסטלית ודמינרליזציה

27. בת 73, ברקע סוכרת ויתר לחץ דם, סובלת לאחרונה מפרפור פרוזדורים. לפי CHA2-DS2-VASC SCORE מה הסיכון לשבץ למטופלת זו?
   א. 4% לשנה
   ב. 15% לשנה
   ג. 25% לשנה
   ד. 40% לשנה

28. באיזה מהבאים יש התאמה בין המבחן לבין המטרה המפורטת?
   א. מבחן BARTHEL מיועד להעריך IADL
   ב. מבחן FIM מיועד להעריך סכנה לנפילות
   ג. מבחן Short Physical Performance Battery (SPPB) מיועד להעריך סרקופניה
   ד. מבחן Time Up and Go מעריך BADL

29. איזה מהבאים מתאר נכונה את הקשר בין ירידה קוגניטיבית לסוכרת?
א. סוכרת מעלה סיכון להופעת דמנציה וסקולרית ולא למחלת אלצהיימר
ב. ירידה קוגניטיבית בחולי סוכרת מעלה סיכון להיפרגליקמיה ולא להיפוגליקמיה
ג. בחולי סוכרת רואים ירידה בתפקודים קוגניטיביים הקשורים לאונה הפריאטלית
ד. בחולי סוכרת קיימת שכיחות מוגברת של פגיעה בתפקודים ניהוליים (EXECUTIVE)

30. איזה מהבאים נכון בנוגע לירידת שמיעה תלוית גיל?
א. היא לא מושפעת ממחלות רקע כגון סוכרת ומחלות כלי דם
ב. במעל 50% מהמקרים יש מרכיב תורשתי רלוונטי
ג. אין הבדל בין גברים לנשים בשכיחות האבחנה
ד. ניתן לבסס את האבחנה על בדיקת סקירה במרפאה גריאטרית

31. בן 74, ברקע מחלת כלי דם היקפית. מאושפז בסיעוד מורכב עקב פצעים קשיי רפוי בכף הרגל (ראה תמונה מספר 2).
מה הטיפול המומלץ?
א. הטריה כירורגית
ב. אנטיביוטיקה סיסטמית רחבת טווח
ג. הפחתת לחץ ומעקב
ד. גרב אלסטית

32. בן 80 מתלונן לאחרונה על כאבי גב, לא ממוקמים, עם מהלך איטי והדרגתי. איזו אבחנה מתאימה לתלונות?
א. אוסטאוארתריטיס
ב. מתיחת שריר
ג. שבר דחיסה בחוליות
ד. פריצת דיסק חריפה

33. מה מהבאים מהווה אינדיקציה לטיפול קבוע בחמצן ביתי קבוע לפחות 16 שעות ביום, במטופל עם COPD?
א. PaO2 < 55 mmHg במנוחה
ב. FEV1> 60%
ג. Hematocrit < 45%
ד. קוצר נשימה וסטורציה 88% במאמץ.

34. בת 65 מתלוננת על הפרעות בשינה. במהלך השינה צועקת ומרביצה לבן זוגה. בבוקר אינה זוכרת את שאירע. מה מתאר נכונה את המצב?
    א. המצב שכיח בנשים וקשור בהזדקנות תקינה
    ב. המצב קשור בדום נשימה בשינה ויש לשקול שימוש ב- CPAP
    ג. מצב זה יכול להקדים הופעה של מחלת פרקינסון
    ד. מדובר בהפרעת התנהגות על רקע דמנציה ויש צורך בטיפול אנטיפסיכוטי

35. מה קרה לאחוז הזקנים שמקבלים השלמת הכנסה בין השנים 2005 ו – 2018?
    א. עלה
    ב. ירד
    ג. עלה עד 2010 ואז התחיל לרדת
    ד. ירד עד 2010 ואז התחיל לעלות

36. בת 70, מסיימת שיקום, 6 שבועות לאחר CVA שהשפיע על ה- Left Parietal Lobe. אין לה שום פגיעה מוטורית שארית, וחולשת יד ימין איתה התייצגה חלפה לחלוטין. עם זאת, היא מביעה תסכול מכך שלא מצליחה לבצע פעולות בסיסיות כגון לבוש, שימוש בסכין ומזלג, או סירוק השיער. היא מבינה את ההנחיות, יכולה לתאר במילים את רצף הפעולות הנדרש, אך לא מצליחה לייצר את התנועות הנדרשות באופן מותאם על מנת לסיים את המשימה.
    כיצד נקראת התופעה שאותה מציגה המטופלת?
    א. Ataxia
    ב. Neglect
    ג. Apraxia
    ד. Agnosia

37. באיזה מהבאים מתוארת התוצאה המתאימה לפגיעה בעצב המפורט?
    א. פגיעה בעצב V (TRIGEMINAL) תגרום להפרעה ב- CORNEAL REFLEX
    ב. פגיעה בעצב IX (GLOSSOPHARYNGEAL) תגרום לאטרופיה ופסיקולציות בלשון
    ג. פגיעה בעצב XII (HYPOGLOSSAL) תפגע בתנועות של שריר הטרפזיוס
    ד. פגיעה בעצב VII (FACIAL) תפגע בתנועות הראש לצדדים

38. בן 86, סובל מדמנציה בדרגת חומרה בינונית, עד לאחרונה פקד מועדון יום. מתקבל למיון עם כיב איסכמי ברגל ימין. הותחל טיפול באנטיביוטיקה תוך ורידית וזקוק לכריתה של הגפה בימים הקרובים. למטופל הנחיות מקדימות לפי חוק החולה הנוטה למות ויפויי כח מתמשך אשר לא הופעל. הצוות מתרשם כי אינו כשיר לתת הסכמה מדעת.
כיצד מקבלים הסכמה לניתוח במקרה זה?
א. למטופל הנחיות מקדימות בתוקף ויש לפעול לפיהן
ב. ניתוח כריתה בחתימה של 3 רופאים
ג. קבלת הסכמה של מיופה הכח והפעלת תוקף יפויי כח באופן מיידי
ד. מנוי אפוטרופוס לצורך פעולה דחופה

39. אילו מהמדדים הריאתיים הבאים עולה פיזיולוגית עם הזדקנות?
א. Residual Volume – RV
ב. Forced Vital Capacity - FVC
ג. Forced Expiratory Flow 1 sec – FEV1
ד. Diffusing Capacity – DLCO

40. בן 73, בימים האחרונים אינו מרוכז, ישנוני, סובל ממחשבות שווא והזיות ראיה שמחמירות בשעות הערב. אינו מודע למצבו. מה מומלץ לעשות?
א. התחלת טיפול אנטיפסיכוטי וברור הסיבה לפסיכוזה
ב. ברור הדמייתי בשאלה של דמנציה
ג. התחלת טיפול נוגד דיכאון
ד. ברור מקיף בשאלה של דליריום

41. איזה מהבאים מהווה גורם סיכון לסרטן שד בנשים?
א. וסת ראשונה בגיל מאוחר
ב. לידות מרובות
ג. שתיית אלכוהול
ד. תת משקל

42. בן 75, ברקע פרקינסון. התסמינים המוטורים החלו בגיל צעיר והחלו בצד שמאל, ניכר שסובל מברדיקינזיה משמעותית ורעד.
איזה מבין נתוני החולה שתוארו, מהווה גורם סיכון לפתח דמנציה בפרקינסון?
א. הופעת תסמינים מוטורים בגיל צעיר
ב. רעד
ג. ברדיקינזיה
ד. תסמינים מוטורים שהחלו משמאל

43. מהי כמות החלבון המומלצת לשיפור תפקוד מסת שרירי בקשיש סרקופני ללא מחלות רקע?
א. 0.6-0.8 גרם/ק"ג
ב. 1-1.2 גרם/ק"ג
ג. 1.4-1.6 גרם/ק"ג
ד. 2 גרם/ק"ג

44. מה מאפיין פיזיולוגיה של הזדקנות הכליה?
א. פרוטאינוריה
ב. זרימת הדם לכליה עולה
ג. ירידה בנפח הכליה
ד. עלייה בקראטינין בדם

45. איזה מהבאים מתאר נכון את הממצאים בנוגע לשינויים בתגובה לאינסולין עם הגיל?
א. קיימת עליה ברגישות לאינסולין
ב. עליה בכמות רקמת השומן קשורה בירידה ברגישות לאינסולין
ג. קיימת ירידה בפעילות הגופנית שמעלה רגישות לאינסולין
ד. לא נמצא שינוי ברגישות לאינסולין עם הגיל

46. חולה מאושפז לאחר אירוע מוחי קשה ונזקק לעזרה מלאה בתפקודי מיטה ומעברים.
איזו מההנחיות הבאות יש לתת לצוות הסיעודי למניעת פצעי לחץ?
א. הצוות נדרש לשינויי תנוחה יזומים במיטה אחת למשמרת של 8 שעות
ב. יש להקפיד על הגבהת זווית מיטה ל- 30 מעלות רוב שעות היום
ג. במהלך הורדה לישיבה בכסא או כורסא יש להקפיד על הגבלה פיזית למניעת החלקה
ד. בשכיבה יש למנוע לחץ בעקבים ולשמור אותם "צפים" באוויר על ידי כרית או אביזר אחר

47. בן 64, הסובל מסכיזופרניה מגיל 20, נמצא במעקב פסיכיאטרי מסודר. עצמאי בתפקודי היומיום הבסיסיים (BADL), זקוק לעזרה והכוונה בתפקודים האינסטרומנטליים (IADL), יוצא לעבודה מוגנת. התגורר עד לאחרונה עם הוריו, שמתקשים לתמוך בו.
מה ההגדרה המתאימה עבורו לצורך מיסוד?
א. תשוש נפש
ב. תשוש
ג. נכה נפש
ד. סיעודי חלקי

48. בן 65, יד ימין דומיננטית, מאושפז בשיקום נוירולוגי לאחר CVA איסכמי ב- MCA השמאלי.
הוא מגיע עם המיפרזיס מימין וקשיים בשפה.
בבדיקה נראה שמבין את מה שנאמר לו וממלא הוראות פשוטות, אך הוא לא מצליח להביע את עצמו באופן מילולי וממציא מילים (neologisms). הוא מתקשה לחזור אחרי משפטים.
מהו סוג האפאזיה ממנה סובל?
א. Wernicke's aphasia
ב. Broca's aphasia
ג. Conduction aphasia
ד. Global aphasia

49. בן 73, מגיע למיון עם קוצר נשימה והיפוקסמיה, איזו מהמחלות הבאות יכולה להיות סיבה ל- HIGH OUTPUT HEART FAILUR?
א. Hypothyroidism
ב. Vitamin B1 deficiency
ג. Amyloidosis
ד. Cachexia

50. מהו מנגנון הפעולה של Finasteride (Propecia) ?
א. חסימת ההמרה של דיהידרוטסטוסטרון לטסטוסטרון
ב. עיכוב האנזים 5 Alpha Reductase
ג. עיכוב האנזים Phosphodiesterase type 5
ד. חסימת הפוספורילציה של Estradiol

51. איזה מהשינויים הבאים מתרחש באופן פיזיולוגי בתפקודי התריס בגיל המבוגר?
א. ישנם פחות נוגדנים עצמיים
ב. TBG (Thyroid-binding globulin) עולה
ג. רמות T4 יורדות
ד. TSH עולה

52. איזה מהתהליכים הפתופיזיולוגיים הבאים קשור בהופעת עצירות בגיל המבוגר ?
א. ירידה בקישור האנדורפינים בפלסמה לקולטנים במעי
ב. עליה בשקיעת קולגן במעי הגס
ג. עליה בפעילות העצבית המעכבת לשרירים הצירקולריים במעי
ד. עליה בפעילות הפלקסוס המיינטרי

53. מה הטיפול המתאים לפצע המופיע בתמונה מספר 3 ?
   א. Hydrocolloids – כגון Granuflex
   ב. Hydrogels - כגון Hydrogel
   ג. Alginates – כגון Kaltostat
   ד. Hydrofibers – כגון Aquacel

54. מי מהמטופלים הבאים מתאים לאבחנה של RHEUMATOID ARHTHRITIS?
   א. בן 77, סינוביטיס בברך מזה חודשיים, שקיעת דם מוחשת, RF שלילי
   ב. בת 72, כאבים בכתפיים ובברכיים מזה חודש, שקיעת דם מוחשת, RF חיובי
   ג. בת 84, סינוביטיס במפרקי הידיים דו צדדית מזה חצי שנה, CRP מוגבר, RF חיובי
   ד. בן 85, כאבים בכתפיים ובגב מזה שנה, שקיעת דם תקינה, RF חיובי

55. מבין התרופות הבאות ל- COPD מי מעלה סיכון לפרכוסים?
   א. Tiotropium Bromide (Spiriva)
   ב. Ipratropium Bromide (Aerovent)
   ג. Theophylline (Teotrim)
   ד. Fluticasone Propionate (Flixotide)

56. בן 78, מאובחן כשנה עם מחלת פרקינסון. סובל מנדודי שינה וסיוטים המופיעים בדרך כלל לפחות 90 דקות לאחר תחילת השינה. בנוסף, מתלונן על היעדר חוש ריח ועצירות.
   מה הטיפול התרופתי המומלץ?
   א. Brotizolam (Bondormin)
   ב. Melatonin (Circadin)
   ג. Zolpidem (Stilnox)
   ד. Zopiclone (Nocturno)

57. לפי המאמר Advanced Dementia של Mitchell, איזה מהבאים הוא קריטריון לפרוגנוזה של תוחלת חיים קצרה מ- 6 חודשים במטופל עם דמנציה מתקדמת בשלב FAST 7C?
   א. שלושה פצעי לחץ דרגה 2
   ב. צלוליטיס
   ג. מבחן MMSE פחות מ- 5
   ד. היפואלבומינמיה 2.2 גרם לדציליטר

58. בן 77, נושא טרכאוסטום, לאחר גמילה מהנשמה ממושכת, ללא צורך בסקשיין. עבר שיקום וכעת זקוק לעזרה ברחצה ובלבוש, הולך עם הליכון בעזרת מטפל מספר צעדים, אינו שולט על סוגר השתן. איזו מסגרת מתאימה להמשך טיפול בו?
    א. מחלקה למונשמים כרוניים
    ב. מחלקה תת אקוטית
    ג. מחלקה לסיעוד מורכב
    ד. מחלקה סיעודית

59. מי מהבאים מעלה סיכון למחלת פרקינסון?
    א. עישון סיגריות
    ב. חשיפה למתכות כבדות כמו מנגנז
    ג. שתיית קפה מעל 5 כוסות ליום
    ד. מגדר נשי

60. מה נכון לגבי הטיפול ב- Hydralazine באי ספיקת לב?
    א. מומלץ למטופלים שלא יכולים לסבול טיפול בחסמי ACE
    ב. מעלה תמותה
    ג. ניתן פעם ביום
    ד. קיימת קונטראינדיקציה לשילוב עם ניטרטים

61. באיזה מהבאים מתואר שילוב נכון של תרופה לטיפול באלצהיימר עם תופעת הלוואי שלה?
    א. Donepazil - טכיקרדיה
    ב. Galantamine – עליה במשקל
    ג. Rivastigmine – אצירת שתן
    ד. Memantine – כאבי ראש

62. למי מהחולים הבאים יש להתחיל טיפול תרופתי באנטי-פסיכוטיים באשפוז?
    א. בת 79 עם דליריום היפואקטיבי שממתינה לשיקום, כרגע שיתוף פעולה לקוי על רקע קושי במילוי הוראות. היועץ השיקומי הודיע כי המטופלת לא תעבור למחלקת שיקום עד שהדליריום ישתפר.
    ב. בת 82 עם UTI, שבלילות ממלמלת ומדברת. שכניה מתלוננים שקשה להם לישון עמה.
    ג. בן 91 עם שבר מורכב בירך. בלילות מנסה לצאת מהמיטה ולחזור הביתה. הוא צועק על המטפלת הצמודה שלו בלילות שהיא מחזיקה אותו בכלא על מנת להרעיל אותו ותולש מעצמו ציוד רפואי.
    ד. בן 88 עם דמנציה קלה ברקע, במחלקת כוויות לאחר שפך על עצמו בטעות סיר מרק רותח. רוב הזמן משתף פעולה עם הצוות אך בכל פעם שהצוות בא להחליף לו חבישות צורח "לא, לא, לא" משתולל ומרביץ להם.

63. מהו נזק אפשרי של Tramadol בטיפול בכאב כרוני?
    א. מעלה סף לפרכוסים
    ב. מעלה סיכון לתמותה
    ג. גורם לעצירות בשכיחות גבוהה יותר משאר התרופות האופיואידיות
    ד. גורם לדכוי נשימתי בשכיחות גבוהה יותר משאר התרופות האופיואידיות

64. מבין המצבים הבאים, מה מתאר נכונה קשר בין שינוי פיזיולוגי בזקנה והשפעתו במהלך סביב ניתוח?
    א. ירידה בנוקשות בית החזה ועליה בסיכון לכשל נשימתי
    ב. ירידה במספר הנפרונים וירידה בסיכון לצבירת נוזלים
    ג. ירידה בזרימת הדם לדרמיס וירידה ביכולת ריפוי פצע
    ד. ירידה בזרימת הדם לכבד וזמן מחצית חיים קצר של התרופה בדם

65. מה כולל שאלון SARC-F SCREENING TEST?
    א. נפילות
    ב. ירידה במדרגות
    ג. מעברים במיטה
    ד. בדיקת צפיפות עצם

66. בן 78 פונה למיון לבירור חולשה קיצונית, אילאוס, פוליאוריה, ואנורקסיה. ברקע סובל מיתר לחץ דם, מחלת לב איסכמית, אוסטאוארתריטיס. מטופל באופן קבוע ב- FUSID, VASODIP, ו- IBUPROPHEN לפי הצורך. בבירור בקבלתו, החמרה כלייתית חדה עם עליית קריאטינין ל- 2.3 (מבסיס 1.2).
    מה מבין הבאים גרם לתלונות של החולה?
    א. היפונתרמיה
    ב. היפוקלמיה
    ג. היפוקלצמיה
    ד. היפוגליקמיה

67. בן 85, סיעודי בתפקודו ומרותק למיטה, אושפז עקב פצע לחץ מזוהם במלאולוס לטרלי משמאל.
הפצע בגודל 4.0x4.5x.0.5 cm בחלקו מכוסה ברקמה צהובה, מסביב לפצע אודם ונפיחות עם רגישות למישוש, דפקים פריפריים תקינים, במעבדה 13.000 לויקוציטים.
בוצעה הטריה כירורגית וניקוי של הפצע, עם חשיפה של עצם והמשך הפרשה מוגלתית בכמות רבה.
הותחל טיפול אנטיביוטי סיסטמי.
מה הטיפול המקומי המתאים להמשך הטיפול בפצע זה?
א. טיפול ב- VACUM (לחץ שלילי)
ב. חבישת Hydrocolloid
ג. חבישת Allginate עם יוני כסף
ד. חבישה עם פד גזה יבש עם Polydine

68. בן 65 עם רקע של COPD מטופל באופן קבוע במשאף של Salmeterol/Fluticasone. מגיע למיון עם קוצר נשימה. בימים האחרונים שיעול עם ליחה מוגלתית בכמות מוגברת. בבדיקה צפצופים על פני שתי ריאות וסטורציה 91% באוויר חדר.
מעבדה ללא סימנים של זיהום סיסטמי וללא אגירת CO_2.
מה הטיפול המתאים לחולה זה?
א. להתחיל טיפול בסטרואידים דרך הוריד ולהתחיל Noninvasive Positive Pressure Ventilation
ב. אשפוז, מתן חמצן ואנטיביוטיקה דרך הוריד
ג. אינהלציות של מרחיבי סימפונות, פרדניזון 40 מ"ג, אנטיביוטיקה דרך הפה
ד. להעלות מינון של משאף קבוע ולהוסיף משאף Tiotropium, מעקב רופא משפחה מחר

69. בן 79, הגיע למרפאה עם פריחה אורטיקרית בשילוב עם שלפוחיות מוצקות, מלווה בגרד, ללא מעורבות ריריות. מצורפת תמונה מספר 4.
מהי האבחנה המתאימה?
א. PEMPHIGUS FOLIACEUS
ב. BULLOUS PEMPHIGOID
ג. PEMPHIGUS VULGARIS
ד. PARANEOPLASTIC PEMPHIGUS

70. מהי התדירות המומלצת למעקב אקו לב במטופל עם היצרות מסתם אאורטלי א-תסמיני?
א. בהיצרות קלה רק בהופעת תסמינים
ב. בהיצרות בינונית אחת לחמש שנים
ג. בהיצרות קשה פעמיים בשנה
ד. תדירות הבדיקה אחת לשנה ללא קשר לחומרת ההיצרות

71. מה נכון מבחינת סיבוכי מחלת הסוכרת?
   א. יש לחפש את סיבוכי הסוכרת החל מ- 5 שנים מזמן האבחנה
   ב. אלבומינוריה הינה מדד להתקדמות מחלת כליות אך לא לסיכון קרדיווסקולארי
   ג. עלייה בקריאטינין תיראה לרוב עם אבחנת הסוכרת והינה הפיכה ברובה
   ד. אלבומינוריה הינה מדד פרוגנוסטי ומדד לתגובה לטיפול

72. איזה מהבאים נכון בנוגע לשימוש ב-ANTI CCP לאבחנה של RHEUMATOID ARTHRITIS?
   א. ANTI CCP בעל רגישות זהה ל- RF באבחון RHEUMATOID ARTHRITIS
   ב. ANTI CCP עולה עם הגיל ולכן לא מומלץ לשימוש לאבחון בזקנים
   ג. ANTI CCP פחות ספציפי מאשר RF לאבחון RHEUMATOID ARTHRITIS
   ד. ANTI CCP מופרש ממפרקים מודלקים ולא קשור באבחנת RHEUMATOID ARHTRITIS

73. מה מהטיפולים הבאים הוכח כיעיל לטיפול בסרקופניה?
   א. ויטמין D
   ב. תרגול כנגד התנגדות (Resistance)
   ג. תרגול אארובי
   ד. חומצות שומן מסוג אומגה 3

74. מה מאפיין אפידמיולוגיה של פרקינסוניזם אטיפי ("פרקינסון פלוס")?
   א. חולי פרקינסוניזם אטיפי מהווים כשליש ממקרי הפרקינסון
   ב. אנשים שעסקו בספורט מגע (contact sport) נמצאים בסיכון מוגבר לדמנציה על רקע גופיפי לוי
   ג. PSP- Progressive supranuclear palsy מתחיל בגילאי 80 ומעלה
   ד. MSA- Multiple system atrophy הינה השכיחה ביותר בקרב הפרקניסוניזם האטיפי

75. מה הגישה הנכונה לטיפול תרופתי בהפרעות בהתנהגות של דמנציה?
   א. רצוי להגביל בזמן את הטיפול האנטיפסיכוטי ולהפסיק כאשר התסמינים חולפים
   ב. שילוב תרופתי עדיף על טיפול יחיד להפחתת תופעות לוואי
   ג. מינון גבוה התחלתי יכול לעזור בהרגעה מהירה של המטופל
   ד. כאשר מתחילים טיפול תרופתי, הטיפול ההתנהגותי מיותר

76. בן 78, ברקע פרקינסון, בימים האחרונים נצפה על ידי משפחתו אוכל כמויות גדולות של מזון בזמן קצר. התופעה חוזרת על עצמה. לאיזו מהתרופות לפרקינסון ניתן לייחס את התופעה?
   א. Levodopa
   ב. Amantadine
   ג. COMT inhibitor
   ד. Dopamine Agonist

77. מהם 4 המרכיבים הנדרשים להערכת כשירות לקבלת החלטות?
   א. Understanding, Appreciation, Reasoning, Expression
   ב. Memory, Language, Understanding, Appreciation
   ג. Executive Functions, Language, Reasoning, Appreciation
   ד. Understanding, Appreciation, Reasoning, Executive Functions

78. בית חולים חדש בישראל מתכנן את שירותיו באוכלוסייה הזקנה לעוד 10 שנים. איזה מהמשפטים הבאים נכון בנוגע לכך?
   א. כ-20% מהאוכלוסייה בישראל הם בני 65 ומעלה.
   ב. מעל שליש מהאשפוזים צפויים להיות בני 65 ומעלה.
   ג. קופת חולים שאחוז המאושפזים הקשישים אצלה הוא הגבוה ביותר היא קופת חולים מכבי.
   ד. במחלקת כירורגיה צפוי כי כ- 40% מהפצועים קשה בתאונות דרכים יהיו בני ה-65 ומעלה.

79. מה נכון לגבי השפעה של אצטילכולין על תהליכים ותפקודים בגוף ?
   א. הוא מופרש אך ורק במוח
   ב. הוא לא משפיע על יכולת למידה וזיכרון
   ג. הפרשת יתר של אצטילכולין יכולה לגרום לבלבול, הפרעות בהתנהגות והזיות ראייה
   ד. הפחתת מספר נוירונים במעיים שמפרישים אצטילכולין היא אחת מהסיבות של עצירות

80. באיזה מהמקרים הבאים מומלץ טיפול בהטרייה כירורגית?
   א. סימני זיהום פעיל בפצע לחץ דרגה 3 עם הפרשה מוגלתית
   ב. פצע איסכמי עם נמק יבש נרחב
   ג. פצע לחץ unstageable, ללא סימני זיהום, אך עם רקמת פיברין רבה על פני מיטת הפצע
   ד. פצעי לחץ מרובים במטופל עם כשל רב מערכתי

81. מה נכון בנוגע לטיפול ב- Melatonin?
   א. הוכח כמשפר קושי להירדם, נדודי שינה וקושי לשמור על שינה רצופה למטופלים עם דמנציה.
   ב. יכול לעזור בטיפול של פרעת התנהגות שמתרחשת בעת חלום (RBD) למטופלים עם מחלת פרקינסון.
   ג. בנזודיאזפינים מעלים רמת מלטונין אנדוגני, לכן טיפול משולב מומלץ ביותר לשיפור השינה.
   ד. הפסקה מהירה גורמת לתסמונת גמילה.

82. בן 68, ברקע מחלת לב אסכמית, הגדלה שפירה של הערמונית וגלאוקומה. אובחן לאחרונה עם סרטן שלפוחית השתן. סובל מדיכאון, ללא הפרעת שינה והתיאבון שמור. בבדיקות מעבדה: תפקודי כבד תקינים, רמות ויטמין B12, סידן ותפקודי תריס תקינים.
מהו קו הטיפול הראשון לדיכאון במטופל זה?
   א. SSRI's
   ב. SNRI's
   ג. TCA's
   ד. MAO-I

83. בת 80 צלולה ועצמאית כחודש לאחר הורדת גבס לאחר קיבוע שבר בקרסול ימין.
מה ההמלצה בשימוש במדרגות?
   א. בעליה במדרגות- יש לעלות קודם עם רגל ימין
   ב. בירידה במדרגות- יש לרדת קודם עם רגל ימין
   ג. בירידה במדרגות בעזרת מקל יש להחזיק את המקל ביד ימין
   ד. בעליה במדרגות בעזרת מקל יש לעלות קודם את המקל

84. בן 88 עצמאי ושמור קוגניטיבית, נבדק במחלקה לרפואה דחופה עקב דלקת ריאות. הוא מתלונן על שיעול פרודוקטיבי עם ליחה צהובה. אינו מבולבל. סימנים חיוניים: חום 38.5, דופק 100, לחץ דם 146/85, נשימות 20 לדקה. במעבדה - 18,000 לויקוציטים, תפקודי כליה תקינים.
על פי מדד CURB65 מהי הפרוגנוזה והמשך הטיפול המומלץ?
   א. סיכויי התמותה פחות מ- 2%, מתאים לטיפול בקהילה אם יש מערכת תמיכה
   ב. סיכויי התמותה 10%, מתאים לאשפוז במחלקה פנימית
   ג. סיכויי התמותה מעל 20%, מתאים לאשפוז בחדר מוגבר
   ד. סיכויי התמותה מעל 40%, מתאים לאשפוז בטיפול נמרץ

85. מה נכון לגבי הטיפול ב- Sacubitril-Valsartan (Entresto) ביחס למעכבי ACE?
   א. גורם לפחות עליה בקריאטינין
   ב. גורם ליותר עליה באשלגן
   ג. אינו קו ראשון באי ספיקת לב HFrEF
   ד. מעלה יותר סיכון לתמותה

86. בן 75, ברקע מחלת פרקינסון מזה כ-9 שנים. מטופל ב- Dopicar כדור אחד 4 פעמים ביום.
לאחרונה הופיעו תנועות שרירים לא רצוניות דמויות ריקוד.
מה ההמלצה המתאימה?
א. להוסיף טיפול ב – Dopamine Agonist
ב. להמשיך טיפול ב- Dopicar ללא שינוי
ג. להפחית מינון של Dopicar
ד. להוסיף טיפול ב-MAO-B Inhibitor

87. בת 72 עם Rheumatoid Arthritis מטופלת ב- Methotrexate במינון 20 מ"ג פעם בשבוע.
היא מעוניינת בקבלת חיסון שפעת. מהי ההמלצה המתאימה?
א. הפסקה זמנית של Methotrexate לשבועיים
ב. המשך הטיפול ב- Methotrexate ללא שינוי
ג. הורדה זמנית של מינון Methotrexate ל- 10 מ"ג למשך חודש
ד. החלפת הטיפול ל- (Arava) Leflunomide

88. בן 87, מתגורר עם מטפלת צמודה שעוזרת לו ברחצה ובלבוש. מתנייד עם הליכון והשגחה צמודה של המטפלת. סובל מדמנציה. אושפז לאחר נפילה, אובחן שבר בקרסול. טופל ניתוחית.
מה מהבאים יעכב את העברת המטופל לשיקום?
א. פצע לחץ דרגה 4 בעכוז
ב. איסור דריכה למשך 6 שבועות
ג. מצבו התפקודי עוד טרם הנפילה
ד. חוסר שיתוף פעולה עם המטפלים

89. בת 85 ברקע אבחנה של דמנציה על רקע אלצהיימר, עצמאית ב- ADL, מאושפזת לאחר תיקון שבר בצוואר הירך. לפי דיווח צוות סיעודי בערב הייתה באי שקט לא זיהתה את בני המשפחה. בבדיקה בבוקר מתמצאת במקום, בשנה, אך לא ביום בשבוע, יודעת בת כמה היא ובאיזה שנה נולדה, מצליחה לשיים 7 חודשים לאחור ללא טעות.
איזה ממבחני הסקר לדליריום **שלילי** אצל המטופלת?
א. מבחן RADAR שבוצע על ידי צוות סיעודי בערב
ב. מבחן 4AT בבוקר
ג. מבחן CAM המקוצר בבוקר
ד. מבחן UB-2 בבוקר

90. בת 72, ברקע אסטמה. מגיעה למרפאה עם בתה עמה היא גרה. הבת אובחנה עכשיו עם שפעת בעזרת מטוש. האם מסרבת לחיסונים בדרך כלל. כעת מסכימה לחיסון.
איזה טיפול נוסף לחיסון ניתן לתת לה בשלב זה?
   א. Amantadine
   ב. Oseltamivir
   ג. Rimantadine
   ד. פרט לחיסון אין מקום לטיפול נוסף

91. בת 78, מגיעה להערכה גריאטרית כוללנית במרפאה. משקל 54 ק"ג, BMI – 19.2 ק"ג/מ^2.
מהי הבירור הבא שיש להשלים להערכת מצבה התזונתי?
   א. בדיקת דם לרמת אלבומין
   ב. בדיקת דם לרמת פר-אלבומין
   ג. למדוד היקף שרירי ידיים
   ד. לברר לגבי ירידה במשקל לאחרונה

92. מהן ההמלצות לבדיקות סקר במטופל הזקן?
   א. לאחר גיל 65 לא מומלץ לעשות בדיקות סקר לסוכרת
   ב. בדיקת הסקר המומלצת לאיתור ירידה בשמיעה היא בדיקת שמיעה על ידי קלינאית תקשורת
   ג. סקר לסרטן שד מומלץ לנשים עם תוחלת חיים צפויה של מעל 9.5 שנים
   ד. בדיקת הסקר המומלצת לסרטן המעי הגס היא קולונוסקופיה

93. בת 80, מאושפזת במחלקת שיקום לאחר ניתוח החלפת פרק ירך בעקבות שבר. מתלוננת על כאב בטן חזק והקאה שהופיעו באופן פתאומי. בבדיקתה בטן תפוחה, טימפנית, כאבים דיפוזיים, גירוי צפקי שלילי. בוצע צילום בטן המופיע בתמונה מספר 5.
מהי האבחנה המתאימה?
   א. Diverticular Disease
   ב. Acute colonic pseudo-obstruction (Ogilvie syndrome)
   ג. Sigmoid Volvulus
   ד. Stercoral Perforation

94. בת 82 אלמנה ואם ל-2, עצמאית ופעילה, דיירת דיור מוגן פנתה למרפאה עקב ירידה במצב הרוח ובאנרגיה. הוחלט להתחיל טיפול בנוגדי דיכאון.
מה תופעת לוואי משמעותית של תרופות נוגדות דיכאון באישה זו?
   א. דלירים משני לטיפול ב- Paroxetine
   ב. הארכת QT ו- Torsades de Pointes משנית ל- Venlafaxine
   ג. Orthostatic Hypotension משני לטיפול ב- Bupropion
   ד. Serotonin Syndrome משני לטיפול ב- Citalopram

95. בן 72, בריא בדרך כלל, מגיע למרפאה עם תלונות של חולשת שרירים המחמירה במהלך היום ומשתפרת במנוחה. הוא מדווח על קושי בלעיסה, פטוזיס ודיפלופיה שמופיעים במהלך היום. תלונות החלו לפני חודש והחמירו בהדרגה.
מה הבדיקה האבחנתית הראשונה שתזמין למטופל זה?
א. בדיקת נוגדנים לרצטפור של אצטיל כולין (anti-AChR)
ב. בדיקת CT מח
ג. בדיקת CT חזה
ד. סרולוגיה ל- WEST NILE VIRUS

96. בת 82, מגיעה למרפאה בשל כאבים ונוקשות במפרקים, במיוחד בכפות הידיים והברכיים. בבדיקה יש ירידה בטווח התנועה במפרקים המעורבים, נפיחות ואודם במפרקים.
מה נכון לגבי הגישה להמשך הבירור בחולה זו?
א. לאור גיל המטופלת ל- Rheumatoid Factor יש ערך מנבא חיובי גבוה ל- Rheumatoid Arthritis.
ב. לאור גיל המטופלת ESR היא בדיקה פחות ספציפית ועלולה להיות מוגברת גם ללא מחלת מפרקים פעילה
ג. השכיחות של Psoriatic Arthritis עולה עם הגיל ויש לשקול בדיקת HLA B27
ד. כאבי פרקים ושינויים ניווניים במפרקים נפוצים מאוד בגיל זה ואין צורך בבירור נוסף

97. בת 77 נבדקת על ידי ראומטולוג בחשד ל- SLE (Lupus).
איזו מהתרופות הבאות שמקבלת **לא** עשויה להשרות SLE ?
א. Omeprazole
ב. Ramipril
ג. Hydrochlorothiazide
ד. Aspirin

98. כל הנתונים הקליניים הבאים לכאבי גב מהווים RED FLAGS ומצריכים בירור סיסטמי פרט לאחד.
מה **לא** מהווה גורם המחייב בירור סיסטמי?
א. מטופל הסובל מדיכוי חיסוני
ב. ירידה במשקל
ג. שימוש קבוע בסטרואידים
ד. כאב גב מזה שבועיים

99. מה מהבאים **לא** מהווה אינדיקציה לניתוח כריתת בלוטות הפאראתירואיד

א. CCT < 60 mL/min

ב. העדפות המטופל

ג. צפיפות עצם עם T-Score = -2.1

ד. סידן באיסוף שתן 24 שעות> 400 מ"ג

100. כל הטיפולים הבאים פרט לאחד אפשריים לטיפול תומך בקוצר נשימה, בחולה שקוע הכרתית עם COPD מתקדם, במסגרת טיפול סוף חיים.

איזה טיפול **לא** מתאים?

א. אופיואידים

ב. מאוורר

ג. CPAP

ד. סטרואידים

101. בן 85, ברקע סוכרת ויתר לחץ דם. התקבל עקב כאבים בחזה. סימנים חיוניים - דופק 86 לדקה, לחץ דם 56/112, סטורציה 97%.

באק"ג – אוטם לטרלי. מתוכנן לצנתור ו- PCI.

מהן תרופות נוגדות האגרגציה והקרישה המומלצות במצב זה?

א. Aspirin, Heparin, Ticagrelor (Brilinta)

ב. Aspirin, Enoxaparin, Clopidogrel (Plavix)

ג. Aspirin, Heparin, Prasugrel (Effient)

ד. Aspirin, Enoxaparin, Fondaparinux (Arixtra)

102. בת 70, מאושפזת במחלקה פנימית בשל חולשה כללית, עייפות וירידה תפקודית. בבדיקות מעבדה אנמיה. בוצע משטח דם. תמונת משטח הדם מופיעה בתמונה מספר 6.

מה האבחנה המתאימה לפי המשטח?

א. משטח תקין

ב. אנמיה מחוסר ברזל

ג. תלסמיה מינור

ד. אנמיה מחוסר ויטמין B12

103. בת 70 עברה ניקור פלאורלי עם הממצאים הבאים:

יחס חלבון תפליט/דם – 0.7

יחס LDH תפליט/דם - 0.65

גלוקוז 40 מ"ג/ד"ל

מהי האבחנה המתאימה?

א. אי ספיקת לב

ב. תסמונת נפרוטית

ג. תסחיף ריאתי

ד. ראומטואיד ארטריטיס

104. בת 77 התחילה טיפול כימותרפי עקב Acute Myelocytic Leukemia.

איזו הפרעה מטבולית יכולה להופיע לאחר התחלת הטיפול?

א. היפרגליקמיה

ב. היפרפוספטמיה

ג. היפרקלצמיה

ד. היפרתנרמיה

105. בת 78, מאושפזת במחלקה פנימית, מתלוננת על כאבים באזור פי הטבעת ושלשולים מימיים מזה יומיים. סימנים חיוניים תקינים. בבדיקת הבטן – בטן רכה, לא רגישה. בבדיקות המעבדה ללא עליית מדדי דלקת, עליה קלה בתפקודי כליה. בדיקות צואה שליליות לפרזיטים וקלוסטרידיום.

מה השלב הבא בבירור?

א. בדיקה רקטלית

ב. קולונוסקופיה

ג. בדיקת CT בטן

ד. תרבית צואה חוזרת

106. בת 74 אושפזה לבירור עלית חום עד 38.5 מזה שבוע. בתרבית דם אחת התקבלה צמיחה של Srep. VIRIDANS. בהאזנה ללב – אוושה חדשה שלא היתה בעבר. אקו לב (TTE) לא הדגים פתולוגיה משמעותית.

איזה מידע נוסף יאפשר לאבחן על פי DUKE CRITERIA שמדובר באנדוקרדיטיס?

א. ממצא פתולוגי אופייני ב- TEE

ב. הנתונים הקיימים מספיקים לאבחנה של אנדוקרדיטיס

ג. פתולוגיה ב- TEE + ממצאים ווסקולרים

ד. RHEUMATIOD FACTOR חיובי + Roth's spots

107. בת 74, בבדיקת גזים בדם בחדר המיון הממצאים הבאים:

מדד ויחידות מידה	ערך לחולה	ערכי הנורמה
PH	7.26	7.37-7.44
PCO2 mmHg	32	40-51
PO2 mmHg	88	65-105
HCO3 mmol/L	18	22-26
Na mEq/L	140	135-145
Cl mEq/L	112	96-106
K mM/L	5.8	3.5-5

מהי האבחנה המתאימה?

א. שלשול

ב. Renal Tubular Acydosis Type I

ג. Hypoaldosteronism

ד. הרעלת סליצילטים

108. בת 70, מועמדת לביצוע קולונוסקופיה לבירור אנמיה ודם סמוי חיובי. ברקע מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, היצרות קשה של מסתם אאורטלי לאחר TAVI, ידוע על רגישות לפניצילין.

מהי הגישה למניעת אנדוקרדיטיס במטופלת זו?

א. PO Clindamycin

ב. PO Azytromycin

ג. IV Ceftriaxone

ד. אין התוויה לטיפול מניעתי

109. מה מהממצאים הבאים אופייני לתסמונת Takotsubo ?

א. ירידה במוטיליות הקיר הקדמי של הלב באקו לב

ב. הרמות ST באק"ג

ג. רמות תקינות של טרופונין בדם

ד. חסימה של כלי דם בצנתור

110. לבת 75 בוצעה בדיקת אק"ג המופיעה בתמונה מספר 7

מה מהמצבים הבאים יכול לגרום לכך?

א. Hypercalcemia

ב. טיפול ב- Citalopram

ג. טיפול ב- Digoxin

ד. Thyrotoxicosis

111. באיזה מהמצבים הבאים נמצא PULSUS PARADOXUS?

א. אוטם קדמי נרחב

ב. תת תזונה

ג. COPD קשה

ד. אי ספיקת לב

112. בן 76, פנה למיון עקב שלשול דמי, מלווה בכאבי בטן וחום 38. מאנמנזה ידוע על ארוחה משפחתית לפני יומיים.

מה הגורם לשלשול?

א. Staph Aureus

ב. Rotavirus

ג. E.Coli

ד. Clostridium Perfringens

113. בן 89, אושפז עקב אי ספיקה כלייתית חדה עם עליית קראטינין מ- 0.8 ל- 2.5. בבדיקת משקע שתן נמצאו GRANULAR CASTS.

מהי האבחנה המתאימה?

א. חסימה על רקע הגדלה שפירה של הערמונית

ב. טרומבוזיס של ה- Renal Artery

ג. Malignant Hypertension

ד. Acute Tubular Necrosis

114. מה מהבאים מהווה את הסיבוך המאוחר ביותר של אוטם שריר הלב?

א. Left Ventricular Aneurysm

ב. Ventricular Tachycardia

ג. Papillary Muscle Rupture

ד. Pericarditis

115. בן 75, מאושפז במחלקת שיקום אחרי אוטם שריר הלב וירידה תפקודית. במהלך טיפול פיזיותרפי איבד הכרה.

בבדיקה – מחוסר הכרה, לא נושם, דופק לא נמוש. הותחל בהחייאה.

בדפיברילטור ממצאי התרשים המופיע בתמונה מספר 8.

קיבל פעמיים טיפול שוק חשמלי (דפיברילציה) ללא הטבה.

מה הטיפול התרופתי המומלץ בנוסף ל- Adrenaline?

א. Atropine

ב. Magnesium

ג. Amiodarone (Procor)

ד. Adenosine

116. איזה מהבאים מתאר נכון קשר בין תרופה לטיפול בסרטן לבין תופעת לוואי שכיחה שלה?

א. Doxorubicin (Adriamycin) – פגיעה לבבית

ב. Cisplatin - היפרקלצמיה

ג. 5 Fluoro-Uracyl - נוירופתיה פריפרית

ד. Rituximab - טרומבוציטופניה

117. בן 70, הופנה למיון לבירור עצירות וכאבי בטן דיפוזיים מזה מספר ימים. בבירור כעת עדות קלינית ומעבדתית לחסימת מעי דק. מה מהבאים הינו הגורם השכיח ביותר לאבחנה זו?

א. הידבקויות

ב. ממאירות

ג. מחלת קרוהן

ד. טיפול קרינתי לבטן בעברו

118. באיזו מהמחלות הזיהומיות הבאות מומלץ להתחיל טיפול אמפירי ב- Ceftriaxone + Vancomycin?

א. Bacterial Meningitis

ב. Septic Shock

ג. Hospital Acquired Pneumonia

ד. Necrotizing Fasciitis

119. בת 72 מדווחת על נטיה מולדת לדמם בפעולות פולשניות ולידות. ללא דימומים ספונטנים.
בבדיקות המעבדה:

מדד	ערך נורמלי + יחידות	ערך למטופלת
PLT	$150\text{-}450 \times 10^3$	239
PT	9.4-12.5 שניות	17
INR	0.9-1.1	1.9
PTT	25-37 שניות	31 שניות

מה האבחנה הסבירה ביותר?

א. חסר פקטור VII

ב. לופוס אנטי קואגולנט

ג. חסר פקטור VIII

ד. גלנצמן טרומבסטניה

120. בן 75, ברקע ידוע על יתר לחץ דם, אי ספיקת לב, אלכוהוליזם. אושפז לבירור ירידה בתיאבון, ירידה במשקל והופעה של מיימת חדשה. כחלק מהבירור בוצע ניקור מיימת.
מה נכון לומר לגבי המדדים מנוזל המיימת?

א. במידה ומדובר בטרנסודט, קרוב לוודאי מדובר במיימת על רקע אי ספיקת לב

ב. במידה ו- SAAG (Serum Ascites-to-Albumin Gradient) מעל 1.1 g/dL, קרוב לוודאי מדובר ביתר לחץ דם פורטלי

ג. מיימת על רקע אי ספיקת לב (Cardiac Ascites) מאופיינת על ידי רמת חלבון מתחת ל 2.5 g/dL בנוזל המיימת

ד. רמת החלבון בנוזל המיימת מעל 1.5 g/dL מעלה סיכון לפתח SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis)

121. מה מהבאים אופייני למעורבות הפריקרד בחולים אונקולוגיים?

א. מתייצג לעיתים קרובות כטמפונדה

ב. ברוב החולים האונקולוגיים עם פריקרדיטיס נמצא תאים ממאירים בניקור הנוזל

ג. מדידת מרקרים בנוזל לא מסייעת באבחון הנוזל כממאיר

ד. מגיב טוב לטיפול בסטרואידים

122. בן 67, ללא עבר של עישון ופעיל גופנית, מגיע למרפאה עם תלונה על שיעול יבש קוצר נשימה מזה שישה חודשים. בבדיקה יש קרפיטציות אינספירטוריות בבסיסי שתי הריאות ו- Clubbing באצבעות.
בבדיקת תפקודי ריאה יש ירידה ב- TLC, FEV1 ו- FVC ביחס לנורמה וירידה בדיפוזיה (DLCO).
אילו ממצאים נוספים צפויים להיות?

א. בבדיקת High resolution CT נראה תמונה של "חלת דבש"
ב. בבדיקת אקו לב נראה ירידה בתפקוד הסיסטולי
ג. בצילום חזה נראה סימנים של לימפאדנופתיה בשערי הריאה
ד. בבדיקת CT נראה אמפיזמה משמעותית

123. בן 74 הגיע למרפאה עקב בצקות מפושטות. המטופל ללא מחלות רקע ידועות ולא עשה בדיקות דם בשנים האחרונות.
איזה ממצא בבדיקה גופנית מכוון לגורם אפשרי לבצקות?

א. עליה ב- JVP מכוונת לשחמת
ב. ממצא של קריפיטציות בריאות מכוון לאי ספיקת כליות
ג. בצקות פריאורביטליות מכוונות להיפואלבומינמיה
ד. PULSE PRESSURE גבוה מכוון לאי ספיקת לב

124. בת 72, פליטה מאוקראינה, ללא היסטוריה רפואית ידועה, לדבריה בריאה בדרך כלל, לא שותה הרבה אלכוהול, וללא טיפול תרופתי קבוע. הופנתה בשל הרגשה כללית רעה מזה 2-3 ימים. בבדיקות הדם הפרעה משולבת באנזימי כבד. אילו מהממצאים הבאים מכוונים לכך שמדובר בהפרעה ממושכת, ולא אקוטית?

א. רמת ALT גבוהה יותר מאשר AST.
ב. הפרעה בתפקודי קרישה
ג. רמה תקינה של אמוניה
ד. רמת אלבומין מתחת ל 3 gr/dL

125. בן 82, לא ידוע על ירידה קוגניטיבית, ברקע ידוע על שחמת מזה כ- 20 שנים, על רקע כבד שומני. אושפז בשל מספר הקאות דמיות כשעתיים טרם קבלתו, מלווה בדליריום. לציין 3-4 אירועים דומים בשנים האחרונות, אירוע אחרון לפני שנה וחצי, אז עבר קשירת דליות. בקבלתו יציב המודינמית ונשימתית, חום סיסטמי תקין. בבדיקות דם ללא חריגות משמעותיות ביחס לבדיקות קודמות, למעט רמת HB 10, כאשר הבסיס סביב 11, מה נכון לומר לגבי הבירור והטיפול במצבו?

א. המטופל מתאים לחוק החולה הנוטה למות, יש לבדוק אם קיימות הנחיות מקדימות, ולשקול להימנע מטיפולים פולשניים בהתאם

ב. מתן מנת דם, ובמידה וההמוגלובין יישאר יציב עד הבוקר למחרת ויהיה שיפור במצבו הקוגניטיבי, תבוצע גסטרוסקופיה אבחנתית

ג. לנוכח סיכון של 20-30% לתמותה סביב כל אירוע של דימום מדליות, חשוב ליידע את אישתו של המטופל על מצבו, ולהקפיד על מעקב קליני ומעבדתי קפדני

ד. בהיעדר מדדי דלקת מוגברים, ולנוכח חשד נמוך ל- SBP (Spontaneous Bacterial Peritonitis), אין מקום למתן טיפול אנטיביוטי

126. מה אופייני לאפידמיולוגיה הזיהומית במטופלים לאחר כריתת טחול?

א. סיכון מוגבר לזיהומים ויראלים

ב. הסיכון לזיהומים גבוה יותר בשלוש השנים הראשונות לאחר הניתוח

ג. סיכון מוגבר לזיהומים בחיידקים גרהם שליליים

ד. כ- 3-5% מהמטופלים יפתחו זיהום מסכן חיים במהלך חייהם

127. בת 80, פנתה לבירור בשל חולשה גוברת. במעבדה Hb = 8.1, רמת ויטמין B12 = 100 .
מה מהבאים מתאים לאבחנה של חסר ויטמין B12 ?

א. Reticulocyte index = 1.1

ב. MCV=90

ג. LDH מוגבר

ד. תאי מטרה במשטח דם

128. מה מהבאים נכון לגבי פגיעה כלייתית מאמינוגליקוזידים?

א. מאופיינת בהיפרמגנזמיה בבדיקות הדם

ב. יכולה להופיע גם שבוע לאחר סיום הטיפול

ג. תלויה ברמת התרופה בדם

ד. נגרמת כתוצאה מנזק לגלומרולים

129. מה ניתן למצוא בהאזנה במטופל עם איוושה סיסטולית שבאקו לב ממצאים המתאימים ל-Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy?

א. האיוושה תשמע מקסימלית במרווח בין צלעי שני מימין

ב. האיוושה תתגבר בעת הרמת רגלי המטופל

ג. האיוושה תהיה מיד-סיסטולית

ד. תשמע איוושה דיאסטולית אפיקלית נילוות (Austin Flint Murmur)

130. בן 75 עובר בדיקה במעבדת שינה בשל תלונות על נחירות, הפסקות נשימה ליליות ועייפות ונמנום במשך היום.

בבדיקה נמצא AHI of ≥30 events/h.

מה נכון לגבי הטיפול ?

א. טיפול ב-CPAP אינו מוכח כיעיל בטיפול במצבו

ב. שיעור ההיענות לשימוש בסדים מנדיבולריים נמוך יותר ביחס ל-CPAP

ג. גודש באף היא תופעת לוואי של טיפול ב- CPAP

ד. טיפול ניתוחי בדרכי האויר העליונות יעיל יותר מ-CPAP בטיפול במצבו

131. מה ההבדל בסיבוכים בין החלפת מסתם אאורטלי בניתוח לבין TAVI?

א. שיעור התפתחות פרפור עליות גבוה יותר לאחר TAVI לעומת ניתוח

ב. שיעור היארעות שבץ מוחי גבוה יותר אחרי TAVI לעומת ניתוח

ג. צורך בהשתלת קוצב לב באחוז יותר גבוה לאחר TAVI לעומת ניתוח

ד. דלף סביב המסתם (PARAVALVULAR LEAK) בשכיחות נמוכה יותר לאחר TAVI לעומת ניתוח

132. בת 80, אושפזה לבירור אנמיה מחסר ברזל. ברקע דיסליפידמיה ויתר לחץ דם, מטופלת ב-ASPIRIN למניעה ראשונית. בגסטרוסקופיה הודגם כיב בתוכו כלי דם מדמם, בוצעה צריבה והונחו קליפסים. ביופסיה חזרה חיובית להימצאות של Helicobacter Pylori. הותחל טיפול במעכבי משאבת פרוטונים (PPI – Proton Pump Inhibitors), והומלץ על השלמת קורס אנטיביוטי.

מה ההמלצות למטופלת זו?

א. לאירדיקציה מלאה של Helicobacter Pylori יש ליטול טיפול אנטיביוטי רציף במשך 4 שבועות

ב. מומלץ לחדש את הטיפול באספירין תוך שבוע

ג. טיפול במעכבי משאבות פרוטונים (PPI) לשארית חייה

ד. לאחר האנדוסקופיה, יכולה לשתות נוזלים בלבד למשך 48 שעות

133. בן 70, ברקע סוכרת, אי ספיקת לב וממאירות ריאה גרורתית מסוג Small Cell Carcinoma. מתאשפז לבירור השתנה מרובה. כמות שתן ביממה 3.5 ליטר. אוסמולריות השתן 200mosml/L.
מה הסיבה המתאימה לממצאים אלו?
א. Resolving Acute Tubular Necrosis
ב. Uncontrolled Diabetes Mellitus
ג. Hypercalcemia
ד. High dose Furosemide (Fusid)

134. באיזה מהמקרים הבאים צפוי FeNa < 1%?
א. Rhabdomyolysis
ב. Sepsis
ג. Contrast Nephropathy
ד. Pre-Renal Azotemia

135. בת 70, ללא טיפול תרופתי קבוע, במהלך בירור לגרד, אובחנה עם הפרעה באנזימי כבד משולבת מזה כחודש. כחלק מהבירור בוצע US בטן, הודגם כבד קטן במראה שחמתי. המטופלת הוזמנה לצורך השלמת בירור לאתיולוגיה של שחמת. מה ההסבר הנכון לבדיקות שבוצעו לבירור?
א. סרולוגיה להפטיטיס C, מכיוון ש- 80% מנשאי הפטיטיס C יפתחו שחמת תוך 20-30 שנים
ב. פאנל אוטואימוני, כולל נוגדנים אנטי-מיטוכונדריאליים Antimitochondrial antibodies (AMA), אשר חיוביים בכ- 20-40% מחולי Primary Billiary Cholangitis
ג. ביצוע כולנגיוגרפיה על ידי MRCP שהוא אבחנתי ל- Primary Sclerosing Cholangitis
ד. ביצוע אקו לב לאבחנה של Cardiac Cirrhosis

136. מה נכון לגבי המאפיינים הקליניים של Gout ?
א. מרבית הנשים עם Gout הן פרמנופאוזליות
ב. מפרק ה-MTP של הבוהן הראשונה מעורב בכמעט שליש מהמקרים
ג. אצבעות הידיים, שורש כף היד והמרפק מעורבים יותר בזקנים
ד. ההתקפים מתחילים בשכיחות שווה לאורך שעות היממה

137. מי מהבאים מהווה את הסיבה לנטייה לטרומבואמבוליזם בחולי אי ספיקת כליות כרונית מתקדמת ופרוטאינוריה משמעותית?
א. ירידה בפעילות פקטור III
ב. אובדן פקטורים אנטי-קואגולנטים דרך הכליה
ג. אגרגציה אבנורמלית של טסיות
ד. צריכת פרוטרמבין לקויה

138. בן 67, מעשן 20 שנות קופסא. פונה למלר"ד בשל שיעול דמי מזה כיומיים עם החמרה בשעתיים האחרונות, מדד בערך כמות של כוס דם. בבדיקתו: סטורציה 87% באוויר חדר, מתוקנת עם 2 ליטר חמצן ל- 98%. לחץ דם 90/60, דופק 110 לדקה, סדיר.

לאחר וידוא נתיב אוויר מוגן מה יהיה השלב הבא?

א. אמבוליזציה של המערכת הברונכיאלית

ב. ברונכוסקופיה קשיחה בחדר ניתוח

ג. ניתוח לכריתת הממצא המדמם

ד. השכבה ב- Prone Poisition

139. בן 71, ברקע Cardiac Cirrhosis, אי ספיקת כליות עם קריאטנין בסיס סביב 2 mg/dL. מתאשפז בשל דה-קומפנסציה כבדית ומיימת קשה.

במעבדה:

מדד ויחידות מידה	ערך לחולה	ערכי הנורמה
PH	7.36	7.37-7.44
PCO2 mmHg	37	40-51
HCO3 mEq/L	20	22-26
Creatinine mg/dL	2.9	0.67-1.17
Urea mg/dL	270	17-43
Albumin gr/dL	2.1	3.5-5.2
Na mEq/L	135	135-145
Cl mEq/L	105	96-106

מהי הפרעת החומצה בסיס ממנה סובל המטופל?

א. Normal Anion Gap Metabolic Acidosis משולב עם Respiratory Alkalosis

ב. Normal Anion Gap Metabolic Acidosis

ג. High Anion Gap Metabolic Acidosis

ד. High Anion Gap Metabolic Acidosis משולב עם Metabolic Alkalosis

140. בן 82 הסובל ממחלת לב איסכמית ידועה, מאושפז במחלקה גריאטרית לאחר נפילה. המטופל מתלונן על כאבים עזים בחזה.

מה מהווה קונטראינדיקציה לטיפול ב- NITROGLYCERIN במצב זה?

א. עליית לחץ דם מעל 150 סיסטולי

ב. 1st DEGREE AV BLOCK באק"ג

ג. ממצא באק"ג של אוטם ימני

ד. שימוש ב- SILDENAFIL (VIAGRA) לפני שבוע

141. בן 68, דייר רחוב, ידוע על כבד שומני על רקע שתיית אלכוהול, אושפז בשל הפטיטיס משנית לשתייה של 2 בקבוקי ויסקי ערב טרם קבלתו. בבדיקות הדם הפרעה קשה בתפקודי כבד, אושפז באבחנה של הפטיטיס אלכוהולי.

מה הגישה המתאימה לגבי הטיפול בסטרואידים במטופל זה?

א. במידה וה- Discriminant Function מתחת ל- 30, יש להתחיל טיפול בסטרואידים סיסטמיים בהקדם

ב. במידה ותהיה תגובה טובה לטיפול בסטרואידים, יש להמשיכו למשך 28 ימים

ג. בהיעדר תגובה מספקת לטיפול בסטרואידים, יש להציג את המטופל להשתלת כבד

ד. בהיעדר תגובה לטיפול בסטרואידים סיסטמיים, מומלץ להשלים בירור על ידי ביופסיית כבד, לשלילת אתיולוגיות חלופיות

142. מהו השילוב הנכון בין סוג סרטן לסיבוך הזיהומי השכיח?

א. ACUTE MYELOID LEUKEMIA – PNEUMOCYSTIS CARINII PNEUMONIA

ב. CARCINOMA OF COLON – STREP. BOVIS BACTEREMIA

ג. HODGKIN'S DISEASE – STREPTOCOCUS PNEUMONIA

ד. MULTIPLE MYELOMA- GRAHM NEGATIVE UROSEPSIS

143. בן 64 בצום לצורך פעולה דחופה. מצורפות תוצאות בדיקות המעבדה שלו:

מדד ויחידות מידה	ערך לחולה	ערכי הנורמה
Creatinine mg/dL	2.1	0.67-1.17
Glucose mg/dL	120	72-100
Na mEq/L	146	135-145
K mM/L	2.9	3.5-5
Ca mg/dL	9.1	8.5-10.5
Albumin gr/dL	4	3.5-5.2

מאיזו תמיסה במתן תוך ורידי מומלץ להימנע במקרה זה?

א. Ringer`s lactate

ב. Saline 0.9% + KCl 40 mEq

ג. Saline 0.45% +KCl 20 mEq+ Dextrose 5%

ד. Saline 0.45% +KCl 40 mEq

144. בן 70, מובא למלר"ד ע"י אשתו. היא מדווחת כי ביומיים האחרונים הוא מבולבל, מתנהג בצורה מוזרה, נראה בדכאון ועם קושי להתרכז. כמו כן הוא מתלונן על כאבים ברום הבטן, ובחילות.
בבדיקת א.ק.ג נצפה הא.ק.ג המופיע בתמונה מספר 9.
איזו הפרעה אלקטרוליטרית צפוייה להימצא את המטופל?

א. היפרנתרמיה
ב. היפרקלצמיה
ג. היפרקלמיה
ד. היפרפוספטמיה

בשאלות הבאות יש לסמן את התשובה הלא נכונה

145. מה **לא** מהווה חלק מפרוטוקול הטיפול האקוטי בהיפרקלמיה?

א. IV NaHCO3 50 ml over 5 minutes
ב. IV Furosemide 40 mg – push
ג. IV Insulin 10 U - push
ד. IV Calcium gluconate 10% 10 ml over 2-3 minutes

146. איזה מהמאפיינים הבאים **אינו** מתאים ל- Viral Encephalitis ?

א. רמות גלוקוז תקינות ב- CSF
ב. אמפליטודות גבוהות וגלים איטיים ב- EEG
ג. שינויים פרונטו-טמפורליים ב- MRI
ד. לימפוציטוזיס ב- CSF

147. כל הרפלקסים הבאים קשורים לפגיעה בגזע המוח בחולה ב- Coma פרט לאחד.
איזה רפלקס **לא** קשור לפגיעה בגזע המוח?

א. PUPILARY LIGHT REACTION
ב. OCULOVESTIBULAR REFLEX
ג. CORNEAL REFLEX
ד. DEEP TENDON REFLEX

148. איזה מהפרמטרים הבאים **לא** נכלל באומדן SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment):

א. Platelets
ב. Bilirubin
ג. Creatinine
ד. Respiratory rate

149. איזה מהבאים **אינו** נכלל בבירור ראשוני ל- FUO ?

א. US בטן

ב. PEP

ג. ANA

ד. אקו

150. כל התרופות הבאות גורמות לנויטרופניה **פרט ל-**

א. Clozapine

ב. Carbamazepine

ג. Lithium

ד. Chloramphenicol

בהצלחה